

Trabajo Práctico: Demencia Tipo Alzheimer

1. Defina que es la enfermedad de Alzheimer y cuáles son los síntomas característicos:

La **Enfermedad de Alzheimer (EA)** es la causa más común de demencia. Se define como una **enfermedad neurodegenerativa progresiva** con déficits funcionales, enmarcado en un espectro clínico cognitivo-conductual específico.

El término **Demencia**, en general, implica un **deterioro cognitivo progresivo** con déficits en varias áreas cognitivas. Un requisito fundamental para el diagnóstico de demencia es que los déficits cognitivos y conductuales deben interferir con las actividades de la vida diaria (AVD) y la independencia funcional.

Síntomas característicos:

La manifestación inicial más frecuente de la EA es la **alteración de la memoria**, siendo el ejemplo clásico del síndrome amnésico anterógrado.

Los síntomas iniciales y comunes que pueden encontrarse en una consulta inicial incluyen:

1. **Déficit en el aprendizaje y en retener información nueva (Memoria reciente):** Repetir la misma pregunta en un período corto de tiempo. Olvidarse de eventos que pasaron hace horas o días, conversaciones recientes, nombres de parientes o amigos.
2. **Déficits de lenguaje:** Problemas para encontrar palabras. Dificultades en la conversación. En la evolución clásica, inicialmente progresan desde una dificultad para encontrar palabras hasta déficits nominativos y de comprensión.
3. **Déficits en habilidades espaciales y orientación:** Perderse en lugares familiares. Dificultades en vestirse y en reconocer un objeto o una persona.
4. **Déficits en razonamiento o en pruebas complejas (Funciones Ejecutivas):** Pérdida de interés o inhabilidad para hacer *hobbies*. Dificultades para manejar dinero o finanzas. Problemas con las compras, la preparación de la comida, o el manejo de la casa o de un vehículo.
5. **Alteraciones en el ánimo o conducta (Síntomas Neuropsiquiátricos):** Cambios sutiles en las relaciones interpersonales. Ansiedad o depresión. Perseveración. Agitación en la forma de paranoia o irritabilidad.

2. Describa los procesos patogénicos de la enfermedad, ¿cuáles son las áreas comprometidas?

La patología de la EA implica varias alteraciones a nivel microscópico y neuroquímico:

1. **Acumulación de Placas Amiloides entre neuronas:** El beta-amiloide es un fragmento de una proteína llamada Proteína Precursora de la Amiloidea (APP). En un cerebro sano, estos fragmentos son destruidos y eliminados, pero en la EA, se acumulan formando placas duras e insolubles.
2. **Formación de Ovillos Neurofibrilares:** Estos son depósitos intracelulares que dependen de la proteína tau. La proteína tau es una proteína estructural que, al ser hiperfosforilada, cambia de forma y se agrega en ovillos que alteran la estructura de la neurona.
3. **Pérdida Neuronal y Sináptica:** La formación de placas amiloides y ovillos neurofibrilares contribuye a la degradación de las neuronas cerebrales y a la aparición de los síntomas clínicos.
4. **Disfunción Neuroquímica:** Se observa una **disfunción colinérgica**, que conduce a trastornos mnésicos. También hay desregulación de aminas biógenas centrales, lo que se relaciona con trastornos conductuales.

Áreas Comprometidas:

A nivel macroscópico, se observa **atrofia cerebral** (particularmente posterior), y el peso cerebral se reduce aproximadamente un 20%. Las áreas afectadas son: **Corteza Cerebral, Frontal y Temporal, Complejo Hipocámpico, y Áreas Límbicas y de Asociación**. Generalmente, el cerebelo y el tronco son normales.

3. ¿Cuáles son las funciones cognitivas comúnmente afectadas? Describa ejemplos para cada una de ellas.

Memoria (Reciente / Aprendizaje): La dificultad en la memoria reciente, el aprendizaje y el almacenamiento de información es el síntoma inicial más frecuente.

- **Ejemplos:** Repetir la misma pregunta en un corto período de tiempo; Olvidarse de eventos o conversaciones recientes; Olvidar nombres de parientes o amigos; Desorientación temporal o geográfica.

Lenguaje: Inicialmente se manifiesta como dificultad para encontrar palabras (déficits nominativos).

- **Ejemplos:** Problemas para encontrar palabras en la conversación; Dificultades en la conversación. En fases posteriores, aparecen parafasias y deterioro de los aspectos semánticos.

Funciones Visuoespaciales y Orientación: Déficits en la habilidad para procesar información espacial y orientarse.

- **Ejemplos:** Perderse en lugares familiares; Dificultades en vestirse; Dificultades en reconocer un objeto o una persona (agnosia).

Funciones Ejecutivas y Razonamiento Abstracto: Dificultad para planificar, manejar problemas complejos y realizar actividades instrumentales.

- **Ejemplos:** Pérdida de la habilidad para realizar actividades cotidianas como: organizar las finanzas/impuestos, hacer compras, preparar la comida, o manejar. Dificultad para manejar problemas complejos. Pérdida de interés o inhabilidad para hacer *hobbies*.

4. ¿Qué criterio se utiliza para considerar que el paciente está en un estadio o el siguiente?

El criterio fundamental se basa en la **pérdida de la independencia funcional** y la severidad del deterioro cognitivo y funcional, a menudo utilizando la escala **Clinical Dementia Rating (CDR)**.

La distinción clave entre el Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y la EA Inicial (Demencia) es la funcionalidad:

- **DCL:** El DCL se caracteriza por déficits leves de la cognición sin **compromiso manifiesto de las capacidades funcionales** del sujeto. El rendimiento en las actividades de la vida diaria es normal. Aunque puede haber un mínimo deterioro en funciones instrumentales complejas.
- **EA Inicial (CDR 1):** El paso a la EA (demencia) ocurre cuando los déficits cognitivos y conductuales comienzan a **interferir con las actividades de la vida diaria (AVD)** y la independencia funcional. En el CDR 1, hay una **pérdida de la independencia funcional** (dificultades con el manejo del dinero, la habilidad para hacer el trabajo o tareas domésticas, y desorientación espacial). El paciente es incapaz de funcionar independientemente en actividades complejas como finanzas o compras.

El **Clinical Dementia Rating (CDR)** es una de las escalas de severidad utilizadas para monitorear el curso evolutivo de la EA y definir sus estadios:

Estadio (CDR)	Criterio de Transición basado en Función/Juicio	Criterio de Memoria
Cuestionable (CDR 0.5)	Deterioro dudoso o leve en actividades de la vida diaria (AVD). Solo deterioro dudoso en la resolución de problemas.	Olvidos de poca importancia.
EA Inicial (CDR 1 / Leve)	Pérdida definitiva de la independencia funcional (dificultades con el manejo del dinero, trabajo o tareas domésticas). Incapaz de funcionar independientemente en estas actividades, aunque puede aparecer normal en contacto casual.	Olvidos consistentes leves; el defecto interfiere con actividades diarias.
EA Moderada (CDR 2)	Ninguna pretensión de funcionamiento independiente fuera del hogar. Depende de otros para las AVD complejas como finanzas, compras o transporte. Manejo de problemas gravemente deteriorado.	Grave pérdida de memoria, más marcada para acontecimientos recientes; retención exclusiva de material muy importante.
EA Severa (CDR 3 / Grave)	Necesita supervisión las 24 horas . Requiere mucha ayuda para el cuidado personal (vestirse, lavarse). Incapaz de intentar juicios o resolver problemas.	Grave pérdida de memoria, solo quedan fragmentos.